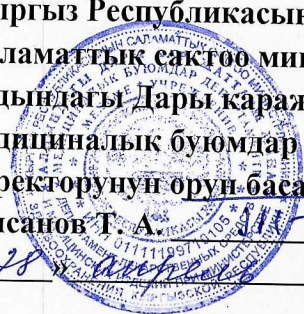


БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар департаментинин
директорунун орун басары
Кысанов Т. А.
« 28 » _____ 2025-ж.



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

АВТОРИЯ

Соодадагы аталышы
Автория.

Эл аралык патенттелбеген аталышы
Гидроксизин

Дарынын түрү
Жука чел кабык капталган таблеткалар.

Курамы

Жука чел кабык капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Гидроксизин гидрохлориди USP 25 мг

Көмөкчү заттар: лактоза, суусуз кальций гидрофосфаты, жүгөрү крахмалы, микрокристаллдуу целлюлоза, повидон, метилгидроксibenзоат, пропилгидроксibenзоат, магний стеараты, натрий кроскармеллозасы, коллоиддүү суусуз кремний диоксиди, тазартылган тальк, натрий крахмалгликоляты, тазартылган суу, ак боёгуч (IC-AMS II 1675).

Сүрөттөмөсү

Жука чел кабык капталган, сүйрү, эки жагы томпок, бир тарабында бөлүнүүчү сызыгы бар жана экинчи жагы жылмакай ак таблеткалар.

Фармадарылык тобу

Нерв системасынын ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Психотроптук препараттар. Анксиолитиктер. Дифенилметанден алынгандар. Гидроксизин

АТХ коду: N05BB01.

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы:

Дифенилметандан алынган, орточо анксиолитикалык активдүүлүккө ээ; ошондой эле тынч алдыруучу, кусууга каршы, гистаминге каршы жана м-холиндерди бөгөөчү таасир берет. Борбордук м-холинорецепторлорду жана гистаминдик H1-рецепторлорду бөгөйт жана белгилүү бир субкортикалдуу зоналардагы активдүүлүктү басат. Психикалык көз карандылыкты жана көнүп кетүүнү пайда кылбайт. Клиникалык таасири препаратты ичкенден 15-30 мүнөттөн кийин башталат.

Когнитивдик жөндөмдүүлүккө оң таасир берет, эс-тутумду жана көңүл бурууну жакшыртат. Скелет жана жылмакай булчуңдарды бошондотот, бронходилататордук жана ооруну басандатуучу таасирлерге, карын секрециясын орточо басандатуучу таасирге ээ. Гидроксизин бөрү жатышы, экзема жана дерматити бар оорулуулардагы кычышууну олуттуу азайтат. Узакка ичүүдө токтотуу синдрому жана когнитивдик функцияларынын начарлашы белгиленген эмес. Уйкусуздук жана тынчсыздануусу бар оорулуулар гидроксизинди 50 мг дозада бир жолу же кайталап ичкенден кийин түнкү ойгонуулардын жыштыгынын төмөндөшү, уйкунун узактыгы көбөйгөндүгү полисомнографияда көрүнөө көрсөткөн. Тынчсыздануусу бар оорулууларда булчуң чыңалуусунун төмөндөшү препаратты суткасына 3 жолу 50 мг дозада ичүүдө белгиленген.

Фармакокинетикасы:

Сиңирүү - гидроксизин жогору деңгээлде АИЖда сиңет. Стах препаратты ичкенден 2 сааттан кийин белгиленет.

25 мг же 50 мг бир жолку дозада препаратты бир жолу ичкенден кийин чоң адамдарда плазмадагы концентрациясы ылайыгына жараша 30 нг/мл жана 70 нг/мл түзөт.

Биожеткиликтүүлүгү ичкенден кийин 80% түзөт.

Бөлүштүрүү - гидроксизин плазмадагыга салыштырмалуу ткандарда (тактап айтканда териде) көбүрөөк топтолот. Бөлүштүрүү коэффициенти 7-16 л/кг түзөт.

Гидроксизин эненин организмине караганда көбүрөөк деңгээлде түйүлдүктүн ткандарында концентрацияланып, ГЭТ жана бала тонунун тоскоолдугу аркылуу кирет. Метаболиттер эне сүтүндө аныкталат.

Зат алмашуу жана бөлүп чыгаруу - гидроксизин боордо зат алмашат. Негизги метаболит (45%) - цетиризин, ал гистаминдик H1-рецепторлордун блокатору болуп эсептелет. Гидроксизиндин жалпы клиренси 13 мл/мүн/кг түзөт. T_{1/2} чоң адамдарда 14 саатты түзөт. Гидроксизиндин 0.8% гана өзгөрүлбөгөн түрдө заара аркылуу бөлүнүп чыгат.

Өзгөчө клиникалык учурлардагы фармакокинетикасы:

Балдарда чоң адамдарга салыштырмалуу жалпы клиренси 4 эсе азыраак, T_{1/2} 14 жаштагы балдарда 11 саатты, 1 жаш курактагы балдарда - 4 саатты түзөт.

Улгайган курактагы бейтаптарда T_{1/2} 29 саатты түзөт, бөлүштүрүү коэффициенти 22.5 л/кг түзөт.

Боор функциясынын бузулуулары бар бейтаптарда T_{1/2} 37 саатка чейин көбөйөт, кан сары суусундагы метаболиттердин концентрациясы боор функциясын кадимкидей жаш оорулууларга салыштырмалуу жогору. Гистаминге каршы таасири 96 саат бою сакталышы мүмкүн.

Колдонууга көрсөтмө

- чоң адамдардагы тынчсызданууну белгилерине жараша дарылоо
- аллергиялык тери кычышуусунун, анын ичинде холинергиялык жана физикалык типтердеги симптомдорду жеңилдетүү.
- чоң адамдардагы жана балдардагы атониялык жана контакттуу дерматит

Каршы көрсөтмө

- оору таржымалында гидроксизинге же препараттын кайсы-бир курамындагыларга; цетиризинге же башка пиперазинден алынгандарга, аминофиллинге же этилен диаминге жогору сезгичтик;
- порфирия менен жабыркаган бейтаптар
- пайда болгон же QT аралыгы тубаса узарган бейтаптар.
- QT аралыгы узарган бейтаптар, анын ичинде белгилүү жүрөк-кан тамыр оорулары, электролиттердин олуттуу дисбалансы (гипокалиемия, гипомagneмия), үй-бүлөлүк таржымалында жүрөктүн капыстан калыбына келбей токтошу, айкын брадикардия, QT аралыгын узартары жана/же эки багыттуу карынча тахикардиясын пайда кылары белгилүү каражаттар менен айкалыштырып колдонуу.
- мурда олуттуу антигистаминден колко-өпкө жагымсыз таасири болгон астмасы бар бейтаптар
- галактозага көтөрүмсүздүк, лактаза жетишсиздиги же глюкоза-галактоза мальабсорбция

- сейрек тукум кууган маселелери бар бейтаптар
- кош бойлуулук, бала эмизүү мезгили
- 6 жашка чейинки балдардын курагы

Препаратты миастенияда, клиникалык көрүнүштөрү бар эрендик бездин гиперплазиясында, заара чыгаруунун кыйындашында, ич катууларда, көз ичиндеги басымдын жогорулашында, акыл-эстен ажыроодо, карышуу талмаларына жакындыкта; аритмиянын өрчүшүнө жакындыкта; аритмогендик таасирге ээ каражаттарды бир убакта колдонууда; БНС жабыркатуучу башка каражаттар же холиноблокаторлор менен бир убакта (дозасын төмөндөтүү талап кылынат) *этияттуулук менен* дайындоо керек. Оор жана орточо деңгээлдеги бөйрөк алсыздыгы, боор алсыздыгы бар бейтаптарга, түйдөкчөлүү чыпка төмөндөшүндө улгайган курактагы бейтаптарга препараттын дозасын төмөндөтүү талап кылынат.

Колдонуу жолу жана дозалары

Препаратты абдан төмөн таасир берүүчү дозада жана болушунча кыскараак мезгил ичинде колдонуу керек.

Чоң адамдар

Чоң адамдар жана 40 кг ашык салмактагы балдарга, эң жогорку суткалык дозасы күнүгө 100 мг түзөт.

Тынчсыздануу абалдарын белгилерине жараша дарылоо

Стандарттуу дозасы күнүгө бир нече ичүүгө бөлүнгөн 50-100 мг.

Тери кычышуусунун симптомдорун жеңилдетүү

Баштапкы дозасы түнкүсүн 25 мг, зарыл учурларда суткасына үч же төрт жолу 25 мг чейин көбөйтүлүшү мүмкүн.

40 кг чейинки салмактагы, бирок 6 жаштан төмөн эмес балдар

Эң жогорку суткалык дозасы күнүгө 2 мг/кг түзөт.

Салмагы 40 кг ашык балдар жана өспүрүмдөр

Эң жогорку суткалык дозасы күнүгө 100 мг түзөт.

6 жаштан жогору балдар үчүн, 15-25 мг баштап жана баланын салмагына жараша күн сайын бир нече ичүүгө бөлүү менен 50-100 мг чейин көбөйтүлөт.

Дозасы бейтаптын дарылоого болгон реакциясына жараша сунушталган дозасынын диапозонуна ылайыкташуусу керек.

Бейтаптардын айрым топтору

Улгайган адамдар

Улгайган курактагы адамдар үчүн, эң жогорку суткалык дозасы күнүгө 50 мг түзөт.

Төмөнүрөөк доза сунушталат. Бул бөлүштүрүү көлөмү көбөйүшү мүмкүндүгү менен, узартылган таасири жана фармакокинетикасына болушу мүмкүн болгон курактык өзгөрүүлөрдүн таасири, анын ичинде боор зат алмашуусу жана бөйрөк элиминациясы менен байланышкан.

Бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптар

Дозасы орточо же оор бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда 50% төмөндөтүлүшү керек.

Боор алсыздыгы бар бейтаптар

Боор функциясынын бузулуулары бар бейтаптарга суткалык дозасын 33% азайтуу сунушталат. Оор боор оорулары бар бейтаптарга препаратты ичүү сунушталбайт.

Кыйыр таасирлери

Төмөндө көрсөтүлгөн жагымсыз реакциялары органдар жана органдар системасынын жабыркашына жана кездешүү жыштыгына ылайык саналган. Кездешүү жыштыгы төмөнкүдөй негизде аныкталат: *абдан тез-тез* ($> 1/10$), *тез-тез* ($> 1/100$ жана $< 1/10$), *көп эмес* ($> 1/1\ 000$ жана $< 1/100$), *сейрек* ($> 1/10\ 000$ жана $< 1/1\ 000$), *абдан сейрек* ($< 1/10\ 000$). *Белгисиз* (жеткиликтүү маалыматтар боюнча баалоого мүмкүн эмес)

Кан жана лимфа системасы тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- агранулоцитоз, лейкопения
- гемолитикалык аз кандуулук

- тромбоцитопения

Иммундук система тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- аллергиялык реакциялар, анафилактикалык шок, ангионевротикалык шишимик

Зат алмашуу жана тамактануунун бузулушу

Белгисиз

- порфирия
- табиттин жоктугу

Психикалык бузулуулар

Белгисиз

- дүүлүгүү, тынчсыздануу
- аң-сезимдин чаташуусу, багыттын бузулушу
- галлюцинациялар
- уйкунун бузулушу, түнкү жаман түш көрүүлөр
- чүнчүү

Нерв системасы тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- дискинезия
- уйкусуздук
- тынч алдыруучу таасир, үргүлөө, баш айлануу, кош көңүлдүк, баш оору, титирөө жана карышуулар
- психомотордук бузулуулар
- сезимдин бузулушу
- экстрапирамидалдык таасирлер
- талмалар
- кома
- уйкусууроо
- көңүл буруунун бузулушу
- эрксиз кыймыл активдүүлүгү
- темтеңдөө
- булдуруктап сүйлөө
- оозго ачуу даамдын келиши
- бозоруу

Көрүү органы тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- аккомодациянын бузулушу
- көрүүнүн бүдөмүктөшү

Угуу органдары жана тең салмактуулуктун бузулушу

Белгисиз

- кулактын чуулдашы
- лабиринтит
- баш айлануу

Жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- карынча аритмиялары (мисалы, «пируэт» тибиндеги эки багыттуу карынча тахикардиясы), ЭКГда QТаралгынын узарышы
- тахикардия
- жүрөктүн тезден согушу
- гипотония, гиперемия

Дем алуу системасы тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- колко карышуусу
- дем алуу органдарынан бөлүнүп чыккандардын коюуланышы
- чыйкылдап дем алуу

- мурундун бүтүшү, тамактын кургашы
Ашказан-ичеги жолу тарабынан бузулуулар
Белгисиз

- ич катуу, ооздун кургашы, окшуу, кусуу, карынчанын жогору рефлюксу, ич өтүү, курсак үстүнүн оорушу, АИЖнын жогору перистальтикасы
Гепатобилиардык системанын бузулушу

Белгисиз

- боор функциясынын бузулушу

Жалпы бузулуулар, теринин жана тери алдындагы клетчатканын жабыркашы
Абдан сейрек

- чачтын түшүүсү

- экзема

- курч жайылган экзантематоздуу пустулез (КЖЭП)

- токсиндүү эпидермалдык некролиз

- Стивенс-Джонсон синдрому

- көп түрдүү эритема

Белгисиз

- дерматит

- туруктуу дарыдан эритема

- кычышуу, эритема, папулалуу бөртмө, бөрү жатыш

- терчилдиктин жогорулашы

Скелет-булчуң жана байланыштыргыч ткандын оорулары

Белгисиз

- миалгия

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу жолдорунун бузулуулары

Белгисиз

- зааранын кармалышы

- дизурия

Жыныс органдары жана сүт бездери тарабынан бузулуулар

Белгисиз

- приапизм

- импотенция

- эрте башталган айыз

Жалпы бузулуулар жана куйган жердеги өзгөрүүлөр

Белгисиз

- талыгуу, талмоорсуу, чарчоо, титирөө

- дем алуу жолдорунун былжырлуу чел кабыгынын кургашы

- жалпы алсыздык

- көкүрөктүн кысылуу сезими

- ачуулануу

- чыйрыгуу

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Автория опиоиддик анальгетиктер, барбитураттар, транквилизаторлор, уйку келтирүүчү препараттар, этанол сыяктуу БНС жабыркатуучу препараттардын таасирин күчөтөт (айкалыштырууда препараттардын дозаларын жекече тандоо талап кылынат).

Автория бир убакта колдонууда эпинефриндин (адреналиндин) прессордук таасирине жана фенитоиндин карышууга каршы активдүүлүгүнө тоскоолдук кылат, ошондой эле беттагистин жана холинэстераза бөгөөлөрүнүн таасирине тоскоолдук кылат.

Авторияны бир убакта колдонууда атропин, белладонна алкалоиддеринин, жүрөк гликозиддеринин, гипотензивдүү каражаттардын, гистаминдик H2-рецепторлорунун блокаторлорунун активдүүлүгүнө таасир тийгизбейт.

Авторияны MAO басандаткычтары жана холиноблокаторлор менен бирге дайындоодон алыс болуу керек.

Гидроксизин CYP2D6 изоферментинин басандаткычы болуп эсептелет жана жогору дозаларда колдонууда CYP2D6 субстраттары менен өз ара таасирлеринин себеби болушу мүмкүн. Гидроксизин боордо зат алмашкандыктан, боор ферменттеринин басандаткычтары менен бирге дайындоодо анын концентрацияларынын көбөйүшүн күтүүгө болот.

QT аралыгын узартышы жана/же эки багыттуу карынча тахикардиясын пайда кылары белгилүү, мисалы, IA класстагы (мисалы, хинидин, дисопирамид) жана III класстагы аритмияга каршы каражаттар (мисалы, амиодарон, соталол), кээ бир антигистаминдер, кээ бир антипсихотиктер (мисалы, галоперидол), кээ бир антидепрессанттар (мисалы, циталопрам, эсциталопрам), кээ бир малярияга каршы препараттар (мисалы, мефлохин), кээ бир антибиотиктер (мисалы, эритромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин), кээ бир грибокко каршы каражаттар (мисалы, пентамидин), кээ бир ашказан-ичеги дарылары (мисалы, прукалоприд), залалдуу шишикте колдонулуучу кээ бир дарылар (мисалы, торемифен, вандетаниб), метадон дары каражаттары менен бириктирилген дайындоо жүрөк аритмиясынын коркунучун жогорулатат. Ошондуктан, бул препараттар менен айкалыштыруу каршы көрсөтүлгөн.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Гидроксизинди эң төмөн таасир берүүчү дозада жана болушунча азыраак убакытка колдонуу керек.

Гидроксизин менен дарылоону жүрөк аритмиясы менен байланышта болушу мүмкүн болгон белгилер же симптомдор пайда болушунда токтотуу керек жана бейтаптар дароо медициналык жардамга кайрылышы керек.

Бейтаптар жүрөк тарабынан болгон бардык симптомдор тууралуу дароо билдириши керек.

Боор алсыздыгы бар бейтаптар

Препараттын тынч алдыруучу касиеттеринен улам, команын пайда болуу жогору коркунучунан улам оор боор ооруларында жана боор энцефалопатиясы болушу мүмкүндүгүнөн улам боор алсыздыгы бар бейтаптарга аны колдонуудан алыс болуу керек.

Биринчи билиардык циррозго карата экинчи боор дисфункциясы бар оорулууларда гидроксизинди бөлүп чыгаруу бузулат. Боор алсыздыгы бар бейтаптар үчүн дозасы түзөтүлүшү керек.

Препаратты башка борбордук нерв системасын жабыркатуучу препараттар менен же антихолинэргиялык таасирге ээ препараттар менен бир убакта колдонууда дозасын түзөтүү талап кылынышы мүмкүн.

Алкоголду жана гидроксизинди бир убакта колдонуу сунушталбайт.

Аллергияга тери сынамын жүргүзгөнгө чейин бир жумага метохолинге сынам жүргүзгөнгө чейин 96 саат мурда дарылоону токтото туруу керек.

Балдар жана улгайган адамдар дары каражаттарынын кыйыр таасирлерине көбүрөөк кабылдагыч болот.

Бейтаптар аң-сезим жана физикалык жөндөмдүүлүктүн бузулуулары тууралуу эскертилиши керек.

Кош бойлуулук

Препаратты кош бойлуу мезгилде колдонуу сунушталбайт.

Изилдөөлөр репродуктивдик токсиндүүлүгүн көрсөткөн. Адам үчүн дарылык дозасынан олуттуу жогору дозада гидроксизинди куюуда түйүлдүктүн аномалиялары тууралуу маалымдалган.

Гидроксизин бала тонунун тоскоолдугу аркылуу өтөт, бул энесине салыштырмалуу түйүлдүктө жогорураак концентрацияга алып келиши мүмкүн.

Эгерде аял кош бойлуу мезгилде гидроксизиндин жогору дозасын (күнүгө 600 мг) алган болсо, анда жаңы төрөлгөндөрдө төмөнкү көрүнүштөр байкалган: гипотония, кыймылдын бузулушу, анын ичинде экстрапирамиддик бузулуулар, клоникалык кыймыл, бат-бат дем алуу жана тамактануунун бузулушу.

Бала эмизүү

Гидроксизин эне сүтүнө кириши мүмкүндүгү божомолдонот. Анын балага таасири белгисиз.

Гидроксизинди бала эмизген аялдар кабыл албашы керек.

Дары каражатынын унаа каражаттарын же коркунуч келтирген механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир тийгизүү өзгөчөлүктөрү.

Гидроксизин кабыл алган бейтаптар, препарат көңүл буруу концентрациясына жана психомотордук реакциянын ылдамдыгына таасир тийгизиши мүмкүн экендиги тууралуу эскертилиши керек.

Ашыкча доза

Симптомдору: антихолинергиялык таасирлеринин күчөшү, БНС жабыркашы же парадоксалдык түрткү берүү, окшуу, кусуу, эрксиз кыймыл активдүүлүгү, галлюцинациялар, аң-сезимдин бузулушу, аритмия, артериялык гипотензия; сейрек - титирөө, карышуулар, олуттуу дозасынан ашырууда пайда болуучу багытын жоготуу.

Дарылоо: эгерде өзү кускаса, аны жасалма жол менен кустуруу же ашказанды суу менен тазалоо зарыл. Организмдин жашоо үчүн маанилүү функцияларын колдоого багытталган жалпы чаралар жана кийинки 24 саатта уулануу симптомдору жоголгонго чейин бейтаптарга монитордук көзөмөлдөө жүргүзүлөт.

Вазопрессордук таасирди алуу зарылдыгы болгон учурларда норэпинефрин же метараменол дайындалат. Эпинефринди колдонууга болбойт. Атайын антидоту жок. Гемодиализ колдонуу натыйжасыз.

Чыгаруу формасы

Ар бир Алу- ПВХ блистерде пленкалуу чел кабык капталган 15 таблетка.
2 блистер колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында жана балдар жетпеген жерлерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Spey Medical Ltd

Lynton House 7-12 Tavistock Square,

London, WC1H 9LT, UK (Улуу Британия)

үчүн өндүрүлдү

Өндүрүүчү:

Psychotropics India Limited

Plot № 12 & 12A, Industrial Park-II, Salempur,

Mehdood-2, Haridwar, Uttarakhand, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз-дооматтарды кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Аман Фарм» ЖЧК, Кыргыз Республикасы,

Бишкек шаары, Тыныстанов көч.4а үй, 11-батир

E-mail: aman.pharm12@gmail.com